

요도 게실은 소변이 배출되는 관인 요도 옆에 작은 주머니 또는 낭이 생기는 질환으로, 거의 대부분 여성에게 발생합니다. 주머니 안에 소변이 고여 소변 후 흘림, 불편감, 반복 감염, 또는 성교통이 생길 수 있습니다. 수년간 발견되지 않는 경우가 많지만, 진단 후에는 매우 효과적으로 치료할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

대표적인 증상은 “3D”입니다:

- **Dribbling(흘림)** — 소변을 다 본 후 소변이 조금씩 흘러내림
- **Dysuria(배뇨통)** — 소변 볼 때 타는 듯한 통증이나 불편감
- **Dyspareunia(성교통)** — 성관계 시 통증

그 밖에 **반복 요로감염(UTI)**, 절박뇨, 빈뇨, 또는 질 앞벽에서 눌렀을 때 액체가 나오는 압통성 덩어리가 느껴질 수 있습니다.

원인

요도 주변의 작은 분비샘이 **막혀 감염**된 후 요도로 터지면서 소변이 차는 주머니가 생기는 것으로 알려져 있습니다. 암이 아니며, 본인의 잘못으로 생기는 질환이 아닙니다.

용어 설명

요도

소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

게실

속이 빈 관에서 풍선처럼 볼록 나온 주머니.

“3D”

흘림(Dribbling), 배뇨통(Dysuria), 성교통(Dyspareunia).

MRI

수술 전 주머니의 위치와 크기를 확인하는 가장 정확한 검사.

게실 절제술

주머니를 제거하고 요도를 복원하는 수술.

Martius 피판

봉합부 보강에 사용하는 작은 조직 피판.

방광경 검사

얇은 카메라로 요도와 방광 내부를 직접 확인하는 검사.

수술이 꼭 필요한가요? 항상 그런 것은 아닙니다. 증상이 없는 작은 주머니는 경과 관찰만 할 수 있습니다. 그러나 흘림, 반복 감염, 통증, 또는 불편한 덩어리가 생기면 게실 절제술이 근본적인 해결책입니다. 집도의가 수술 전 MRI로 주머니의 위치와 범위를 정확히 파악합니다.

진단 방법

- 신체 검사 — 질 앞벽에서 눌렀을 때 액체가 나오는 압통성 덩어리 확인
- **MRI** — 주머니의 크기와 형태를 확인하는 가장 정확한 방법
- 필요 시 **방광경 검사**로 요도 안쪽의 개구부 확인

치료 방법

- 1 **경과 관찰** — 증상이 없는 작은 주머니는 지켜봅니다.
- 2 **감염 치료 우선** — 감염이 있으면 먼저 치료합니다.
- 3 **게실 절제술** — 질을 통해 주머니를 제거하고 요도를 층별로 복원하며, 필요 시 조직 피판을 이용합니다.
- 4 회복 중에는 **도뇨관**을 유지하고, 제거 전 **치유 확인 X선 검사**를 시행합니다.

알아두세요

- 봉합 부위가 섬세하므로 수술 후 수주간 도뇨관을 유지합니다.
- 대부분 증상이 크게 좋아집니다. 드물게 재발이나 새로운 요실금이 생길 수 있으며, 이 경우 추가 치료가 가능합니다.
- 수술은 감염이 완전히 가라앉은 뒤에 계획합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 오한, 또는 골반 통증이 심해질 때
- 수술 후 **소변을 전혀 볼 수 없거나** 도뇨관이 막혔을 때
- 심한 출혈, 또는 지속적인 새로운 요실금이 생길 때

기억할 세 가지

1. 요도 게실은 요도 옆 작은 주머니입니다 — “3D”(흘림, 배뇨통, 성교통)와 반복 감염을 기억하세요.
2. MRI로 가장 정확하게 확인합니다. 증상 없는 작은 주머니는 경과 관찰, 불편한 주머니는 정교한 복원 수술로 절제합니다.
3. 수술 후 도뇨관 유지와 치유 확인 X선 검사가 필요합니다. 발열, 소변 불통, 또는 새로운 지속성 요실금이 있으면 즉시 연락하세요.